EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67209
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-11 14:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EVARISTA DEL C APARICIO CARO			RUN	: 5.708.494-4
F.Nac	: 16-04-1947	Edad	: 76 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: TRES ESQUINAS DE SAN CARLOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 995572380		
Fecha Ingreso	: 2023-06-20	Fecha Egreso	: 2023-07-11 14:00:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico frontal mesial y cingulo izquierdos con TH PH-2 (+HSD tentorial bilateral) post trombolisis c/rtPA 18/6/23, en regresión
-Herniación subfalcina izquierda 2°
-FA persistente sin anticoagulación
-Traqueobronquitis bacteriana resuelta
-Bacteremia por E Coli MS, HC(+) 1/2
-Bronquitis bacteriana aguda resuelta
-Bacteriuria por E Coli MS resuelta

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Se toma conocimiento del caso, paciente con ant HTA y DM-2, presentó el 18/6 a las 8:50 AM (estando en vigilia) un episodio súbito de hemiparesia FBC derecho. Ingresa a SU HSC con PA 230/110, T 37.1, HGT 246, sat 97 amb, TC cerebro s/c muestra infarto agudo frontal mesial izquierdo posterior ya establecido (tomado a las 10 AM) sin TH, y secuelas frontal y corona radiada/centro semioval derechos, talamico lateral izquierdo, leucoaraiosis confluente Fazekas 3. No se realizó angioTC por falta de contraste. Se presentó caso a neurologo de turno HHM, se toma 2° TC cerebro s/c (11.26), se indicó alteplasa 0.6 mg/kg iniciado a las 13.05h. A las 14.45 presentó vómitos y mirada hacia izquierda, TC cerebro s/c mostró TH PH-2 en zona de infarto (con efecto de masa sobre VL adyacente). Se descartó urgencia neuroquirúrgica y se traslado a UCI HSC para continuar manejo.
Hoy con mejor nivel de PA, se suspendió infusión de labetalol, en monitoreo presentó FA s/RVR que mantiene. Al ex neurologico: vigiil, no emite lenguaje ni sigue órdene, sin intencion comunicativa, impresiona mutista y apatica, retira al dolor en las 4 EE, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, lengua central, ESD M1, ESI M4-5, EEII M2-3 (menor a derecha), algesia impresiona conservada y simétrica, RCP flexor izq y extensor derecho.

Evolución
Paciente REG, HDN estable con HTA leve a moderada, eupneica, afebril, FA s/RVR al monitor, hiperglicemia moderada vespertina, estable en su condición neurológica, impresiona mayor conexión con el medio, balbucea de manera mas consistente, tolera alimentación por SNG, mal control de tronco en sedestación, tos productiva ocasional ni disnea ni aumento del trabajo ventilatorio, impresiona sin molestias, se observa tranquila y sin dolor. Completó ATB por 5 días (pip/tazo) por traqueobronquitis (2° evento infeccioso, previamente ya habia completado tto ATB por bronquitis aguda 2° a E coli).

Exs lab 7/7/23 destaca descenso de PCR y GB, fx renal N, hipokalemia leve, todos los cultivos negativos a la fecha. Exs control de hoy mantiene GB y procalcitonina bajas, K y fx renal N
Diuresis(+) dep(+) diarreicas desde ayer, CD(-).
TC cerebro s/c muestra regresion de TH y HSD, herniacion subfalcina sin cambios. Se decide mantener solo prevencion 2° con AAS y se desestima realizar ETT, por funcionalidad residual incierta, con posible deterioro cognitivo importante 2° a daño vascular.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 11/7/23.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 11/7/23
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Nifedipino 20 mg c/8h
2. -Carvedilol 25 mg c/12h
3. -Hidralazina 50 mg c/6h
4. -Atorvastatina 40 mg/noche
5. -Donepecilo (10 mg) 1/2 comp AM
6. -Levetiracetam 500 mg c/12h
7. -Metildopa (250 mg) 2 comp c/8h
8. -Hidroclorotiazida (50 mg) 1/2 comp al día
9. -Aspirina 100 mg/d
10. -Ipratropio 2 puff c/6-8h SOS
11. -Insulina NPH 10 U AM

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/7/23
-CD(-)
-LF+
-Alb 2.8
-Crea 0.6 MDRD 97.2 Uremia 26
-AU 1.5
-Ca 8.2 Ca corr P 3.5
-FA 87 BI 0.45 BD 0.15 BT 0.6 GOT 29 GPT 26 GGT 26
-Na 135 K 3.8 Cl 101
-Leu 10100 Hb 12.2 Plaq 239000 Seg 84 VHS 32
-Procal 0.03

7/7/23
-Glic 173
-Crea 0.9 MDRD 60.88
-Lact 1
-PCR 23.2
-Na 136 K 3.3 Cl 105
-Leu 8300 Hb 10.8 Plaq 203000 Seg 77 VHS 26
-Procal 0.05

3/7/23
-HC(-)
-CSB(-)
-Urocultivo(-)

OBSERVACIONES:

Ex fco general
-Perfusión e hidratación N, yug no ingurgitadas, rash(-), petequias(-), artritis(-)
-Cardiaco: RII 2T s/s
-Pulmonar: MP(+), estertores escasos, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia

-EE: edema(-), TVP(-), pulsos pedios y tib posteriores no palpables

Ex neurológico
-Mental: somnolienta, bradipsíquica, confusa, lenguaje hipofluente y mayormente ininteligible, no nomina ni repite, sigue órden simple
("abra y cierre la mano izquierda")
-PC: CV impresiona conservado por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria leve, sensibilidad algésica impresiona N, nistagmo(-) lengua y úvula centrales, resto n/e
-Motor: ESI M5, ESD M0-1, EII M1-2, EID M2, RCP extensor bilateral
-Sensitivo: algesia impresiona conservada y simétrica en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO